

Table of Contents

MEMORANDUM PRAWNE UD207 — WERSJA 2.0

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Projekt UD207 w wersji 4.0 opublikowanej 13 maja 2026 r. (przyjęty przez Radę Ministrów 12 maja 2026 r.; kontynuacja prac legislacyjnych po konsultacjach publicznych z czerwca 2025 r.)

Warszawa, 16 maja 2026 r.

Adresaci: — Biuro Analiz Sejmowych — Komisja Zdrowia Sejmu RP X kadencji — Komisja Ustawodawcza Sejmu RP — Komisja Zdrowia Senatu RP — Kancelarie prawne, prawnicy konstytucjonaliści, posłowie i senatorowie zainteresowani analizą prawną projektu

Opracowanie: Pakiet obywatelski UD207 — na podstawie analizy prawnej autorstwa M. (po korektach Perplexity v13 + ChatGPT v14 + Perplexity v15). Pełna analiza w wersji szczegółowej dostępna w Załączniku 1 Policy Paper EBM v1.10, Część B.

Charakter: materiał analityczny; nie stanowi opinii prawnej w rozumieniu obrotu profesjonalnego.

TEZA GŁÓWNA

Projekt UD207 dąży do społecznie legitymowanego celu — ochrony pacjentów przed oszustwami zdrowotnymi — jednak realizuje go za pomocą narzędzia nieprecyzyjnego, nadmiernie represyjnego i systemowo niespójnego. W obecnym kształcie tworzy nowy reżim quasi-karny z karami administracyjnymi do 1 000 000 zł, bez zapewnienia gwarancji wymaganych przez Konstytucję RP, prawo Unii Europejskiej i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Projekt nie wypełnia żadnej rzeczywistej luki, której nie pokrywają już istniejące przepisy karne i administracyjne — a zarazem stwarza poważne ryzyko dla legalnej działalności medycznej, naukowej, dziennikarskiej i rynkowej, w tym dla legalnych terapii eksperymentalnych prowadzonych w trybach przewidzianych prawem UE.

Niniejsze memorandum przedstawia siedem zarzutów głównych (A), sześć zarzutów pomocniczych (B), dziesięć rekomendowanych poprawek legislacyjnych (C) oraz tabelę synoptyczną (D) — w formacie operacyjnym dla biur analiz, kancelarii i prawników parlamentarnych.

A. ZARZUTY GŁÓWNE

A.1. Nieostrość definicji „praktyki pseudomedycznej” (art. 2 Konstytucji RP — *lex certa*)

Art. 67zj ust. 1 opiera delikt administracyjny na trzech pojęciach blankietowych:

— „**aktualna wiedza medyczna**” — pojęcie dynamiczne, zależne od konsensusu naukowego. **Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5.06.2019 r., III KK 212/18** (sprawa z art. 160 § 2 k.k. dotycząca błędu diagnostycznego) wskazał, że ocena zgodności postępowania lekarza z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się *in dubio pro reo* (art. 5 § 2 k.p.k.). Przeniesienie tego kryterium do deliktu administracyjnego — bez analogicznych gwarancji procesowych i z przerzuceniem ciężaru dowodu — rodzi stan arbitralności trudny do pogodzenia z art. 2 Konstytucji.

— „**świadczenie zdrowotne**” — pojęcie znane ustawie o działalności leczniczej, lecz niewystarczająco precyzyjne w reżimie sankcyjnym: wymaga wyraźnego rozgraniczenia od działań edukacyjnych, profilaktycznych, dobrostanowych, dietetycznych, religijnych, coachingowych i dziennikarskich.

— „**publiczne rozpowszechnianie**” — pojęcie niedookreślone w epoce mediów społecznościowych; niejasny zakres: wpisy w zamkniętych grupach, materiały szkoleniowe, wypowiedzi naukowe.

Linia TK wymaga podwyższonego standardu określoności dla regulacji represyjnych: **K 11/94, P 19/06, P 46/13**. W orzecznictwie sygnalizacyjnym TK (postanowienia serii S) wielokrotnie wskazywano nieostrość pojęć represyjnych jako samodzielną wadę konstytucyjną — por. **P 29/13 (TK, 2014)** dot. naruszenia zasady przyzwoitej legislacji z art. 2 Konstytucji.

A.2. Engel + wyłączenie KPA = postępowanie quasi-karne bez gwarancji (art. 6 EKPC, art. 42 ust. 3 Konstytucji RP)

Postępowanie RPP spełnia **wszystkie trzy kryteria Engela** (Engel v. Holandia, 8.06.1976):

— zakaz o charakterze ogólnym (adresowany do całego rynku zdrowia); — represyjny cel normy (sankcja, nie wyrównanie szkody); — surowość sankcji — do 1 000 000 zł.

Spełnienie kryteriów Engela aktywuje pełen standard art. 6 EKPC. Tymczasem **art. 64a ust. 4** projektu w odniesieniu do **decyzji tymczasowej z ust. 3**:

— wyłącza art. 10 KPA (prawo czynnego udziału strony); — wyłącza art. 81 KPA (prawo wypowiedzenia się co do dowodów); — nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy — bez indywidualnej oceny przesłanek art. 108 KPA (sprzeczność z K 22/06 TK).

Połączenie tych konstrukcji rodzi **bardzo wysokie ryzyko kwalifikacji postępowania jako sprawy o charakterze quasi-karnym w rozumieniu art. 6 EKPC przy braku pełnych gwarancji proceduralnych właściwych dla takiej kwalifikacji**. Niezależne

stanowisko 7 organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia z lipca 2025 r. (Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i in.) określa art. 64a ust. 4 jako „rażące naruszenie KPA”.

A.3. Ciężar dowodu (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 EKPC, art. 48 KPP UE)

Art. 67zł ust. 4 przenosi na stronę ciężar wykazania okoliczności egzoneracyjnych z ust. 3 (zaprzestanie praktyki, usunięcie skutków). Samo w sobie nie jest to pełne odwrócenie ciężaru dowodu co do wszystkich znamion. Jednak w połączeniu z brakiem obowiązku organu wykazania rzeczywistej szkodliwości praktyki (wystarczy subsumpcja pod definicję art. 67zj), nieostrością tej definicji, rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wyłączeniem art. 10 i 81 KPA w decyzji tymczasowej, konstrukcja ta **rodzi poważne ryzyko nierównowagi proceduralnej na niekorzyść strony**. Stanowisko 7 organizacji pracodawców (lipiec 2025) podnosi to jako odrębny, samodzielny zarzut konstytucyjny.

A.4. Publikacja przed prawomocnością (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 EKPC, art. 5 i 35 RODO)

Projekt przewiduje trzy mechanizmy ujawniania informacji o praktykach:

— **art. 64a ust. 1–2**: publiczne ostrzeżenie / podanie informacji do publicznej wiadomości w drodze postanowienia, na które służy skarga do sądu administracyjnego; wydawane przed prawomocnością decyzji co do meritum; — **art. 64a ust. 3 (w zw. z ust. 4)**: decyzja tymczasowa o zaniechaniu zachowań z rygorem natychmiastowej wykonalności; do tej decyzji nie stosuje się art. 10 i 81 KPA; — **art. 47 ust. 1b, art. 64 ust. 4a, art. 67zł ust. 5**: publikacja decyzji w całości lub części, na koszt podmiotu, z oznaczeniem prawomocności. KPRM deklaruje anonimizację danych pacjentów.

Problem konstytucyjny nie polega na publikacji danych osobowych pacjentów (są anonimizowane), lecz na publikacji informacji o praktyce/podmiocie przed zakończeniem kontroli sądowej — z nieodwracalnym skutkiem reputacyjnym. ETPC: *Allenet de Ribemont v. Francja* (10.02.1995), *Khuzhin v. Rosja* (23.10.2008). Brak DPIA wymaganej przez art. 35 RODO; brak doprecyzowania retencji, deindeksacji, trybu usunięcia po uchyleniu decyzji.

A.5. Brak luki legislacyjnej — paradoksy farmaceutyczne (art. 31 ust. 3 Konstytucji — proporcjonalność)

Tabela istniejących reżimów represyjnych vs. UD207:

Zachowanie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień

Eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwoleń

Oszustwo medyczne

Nieuczciwa praktyka rynkowa

Naruszenie standardów zawodowych

Pseudomedycyna wg UD207

Istniejące instrumenty są dla zachowań ciężkich surowsze (kara pozbawienia wolności) i precyzyjniejsze (znamiona czynu). UD207 dodaje kolejny reżim represyjny dla zachowań już penalizowanych — bez wypełnienia rzeczywistej luki legislacyjnej. Test proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji budzi poważne wątpliwości.

Paradoks pierwszy (Prawo farmaceutyczne — produkty legalnie dopuszczone):

producent może legalnie sprzedawać homeopatyczny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu przez Prezesa URPL (art. 21 Prawa farmaceutycznego), lecz jego promocja zgodna z funkcją produktu staje się praktyką pseudomedyczną wg art. 67zj. Wewnętrzna sprzeczność legislacyjna niemożliwa do naprawienia bez wycofania projektu lub klauzuli wyłączającej. Analogicznie: suplementy diety (rozporządzenie 1924/2006/WE), wyroby medyczne (rozporządzenie 2017/745), kosmetyki.

Paradoks drugi (compassionate use / named-patient — terapie eksperymentalne legalne w UE):

dyrektywa 2001/83/WE art. 5 ust. 1 oraz rozporządzenie 726/2004 art. 83 przewidują indywidualny dostęp pacjenta do substancji bez dopuszczenia rynkowego. W trybie tym w Niemczech udokumentowano kliniczne podanie salinomycyny (Naujokat C., Steinhart R., J Biomed Biotechnol 2012;2012:950658, DOI 10.1155/2012/950658). Polskie prawo: art. 4 ustawy o zawodach lekarza (autonomia terapeutyczna, wyrok SN z 10.02.2010 r.) i art. 37 Prawa farmaceutycznego (off-label). UD207 nie zawiera wyłączenia — publiczna wypowiedź lekarza o takiej terapii (publikacja, konferencja, wyjaśnienie pacjentowi) może zostać zakwalifikowana jako pseudomedycyna z sankcją 1 mln zł. Tworzy to **arbitralność geograficzną** w obrębie UE i ryzyko kolizji z art. 56 TFUE oraz art. 4 ust. 3 TUE (zasada lojalnej współpracy).

A.6. Dwuinstancyjność i prawo do sądu (art. 78, 45, 176 Konstytucji RP)

Projekt nie zapewnia ścieżki sądowej z merytoryczną kontrolą decyzji — model SOKiK wymagany przez TK SK 27/03 dla decyzji o charakterze represyjnym. Schemat administracyjnoprawny uznany przez TK za niewystarczający. Rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy bez indywidualnej oceny przesłanek narusza linię TK K 22/06.

A.7. Odpowiedzialność osób zarządzających (art. 69b)

Projekt zawiera ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 70), ale nie zapewnia gwarancji właściwych dla odpowiedzialności osobistej:

— brak obrony należytej staranności (due diligence defence); — brak precyzyjnego rozróżnienia zakresu faktycznego wpływu osoby zarządzającej; — brak jednoznacznego standardu winy; — brak mechanizmu zapobiegającego automatycznemu karaniu zarządu za sporne rozstrzygnięcie medyczno-naukowe.

Kara do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia (~ 170 000 zł) kwalifikowana jako „criminal” w rozumieniu Engela aktywuje pełen standard art. 6 EKPC. Sprzeczne z linią TK K 1/14, P 124/15.

B. ZARZUTY POMOCNICZE

B.1. RODO (rozporządzenie 2016/679)

Brak DPIA (art. 35 — ocena skutków dla ochrony danych), brak ograniczenia retencji publikacji, brak mechanizmu prawa do bycia zapomnianym (art. 17), brak pełnej minimalizacji danych (art. 5). Strona internetowa RPP dostępna globalnie — transgraniczne przetwarzanie danych w rozumieniu RODO bez koordynacji z UODO.

B.2. DSA i EMFA (koordynacja, nie automatyczna kolizja)

W zakresie egzekwowania zakazów wobec treści internetowych projekt powinien zostać skoordynowany z DSA (rozp. 2022/2065, art. 16–22 — procedura notice-and-action), zwłaszcza gdy decyzje RPP miałyby prowadzić do usuwania treści z platform hostingowych. W zakresie profesjonalnych publikacji medialnych — wyraźne wyłączenie dla działalności dziennikarskiej zgodnie z Prawem prasowym i standardami EMFA (rozp. 2024/1083).

B.3. Dyrektywa 2005/29/WE (ryzyko kolizji kompetencyjnej)

Projekt powiela zakazy praktyk wprowadzających w błąd, przenosząc je do surowszego reżimu RPP — ryzyko kolizji z zasadą pełnej harmonizacji (VTB-VAB C-261/07, Plus Warenhandelsgesellschaft C-304/08). Wyjątek sektorowy z motywu 9 i art. 3 ust. 3 dyrektywy dotyczy przepisów krajowych o zdrowiu i bezpieczeństwie produktów; rdzeń UD207 to penalizacja komunikatu rynkowego o metodach. Argument formułować jako ryzyko kolizji kompetencyjnej wymagającej harmonizacji, nie jako oczywiste naruszenie.

B.4. Ochrona sygnalistów (dyrektywa 2019/1937, ustawa z 14.06.2024 r.)

Znamiona art. 67zj mogą obejmować osoby ujawniające nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia (lekarz, naukowiec, dziennikarz). Konstrukcja „korzyść majątkowa lub osobista” jest pozornym filtrem — sygnalista, naukowiec budujący dorobek, dziennikarz zarabiający honorarium technicznie spełniają to znamię. Projekt nie zawiera klauzuli wyłączającej dla sygnalistów.

B.5. Art. 17 Konstytucji RP — relacja z samorządami zawodowymi

Projekt tworzy równoległy reżim odpowiedzialności wobec materii pokrywającej się z odpowiedzialnością zawodową lekarzy i innych zawodów medycznych. Problemem nie jest sama kompetencja RPP, lecz brak mechanizmu koordynacji, ryzyko podwójnej odpowiedzialności (ne bis in idem) oraz brak jasnego rozgraniczenia między deliktem administracyjnym a przewinieniem zawodowym.

B.6. Konwencja z Oviedo (argument interpretacyjny)

Polska podpisała w 1999 r., ale nie ratyfikowała Konwencji z Oviedo. Konwencja stanowi europejski standard bioetyczny i argument interpretacyjny dotyczący świadomej zgody oraz autonomii pacjenta. Polska znajduje się w grupie 8 dużych państw nieratyfikujących (obok m.in. Niemiec). Na tle wybranych systemów europejskich, zwłaszcza niemieckiego

Heilpraktiker (od 17.02.1939 r., ok. 50 tys. specjalistów), UD207 wybiera model wyraźnie bardziej represyjny niż regulacyjny. ETPC: **Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia** (302/02, 10.06.2010) — „*The right to make one's own medical choices — including the refusal of particular forms of treatment — falls within the sphere of personal autonomy*” (art. 8 EKPC, art. 9 EKPC).

C. REKOMENDOWANE POPRAWKI LEGISLACYJNE

1. **Fundamentalne przeredagowanie definicji praktyki pseudomedycznej (art. 67zj)** — zastąpienie pojęć blankietowych weryfikowalnymi znamionami zachowań; klauzule wyłączające dla nauki, dziennikarstwa, sygnalistów, świadomych wyborów pacjenta, legalnie dopuszczonych produktów leczniczych, terapii w trybie compassionate use / named-patient / off-label.
 2. **Przywrócenie art. 10 i 81 KPA** w decyzji tymczasowej z art. 64a ust. 3 — lub ograniczenie wyłączenia do sytuacji nadzwyczajnych z przesłanek art. 10 § 2 KPA.
 3. **Usunięcie konstrukcji rodzącej ryzyko nierównowagi proceduralnej** w art. 67zł ust. 4 — przywrócenie pełnej zasady domniemania niewinności.
 4. **Uzależnienie publikacji decyzji** od prawomocności (lub ściśle oznaczenie tymczasowości + tryb usunięcia po uchyleniu) oraz pełna regulacja zgodności z RODO: retencja, anonimizacja, deindeksacja, DPIA, prawo do bycia zapomnianym.
 5. **Wprowadzenie modelu progresywnego sankcji:** ostrzeżenie → upomnienie → kara łagodniejsza → kara surowa; miarkowanie według skali działalności.
 6. **Mechanizm koordynacji** z UOKiK, samorządami zawodowymi, Prawem farmaceutycznym, RODO, DSA i EMFA (test ścisłej konieczności kumulacji wg TSUE Menci, Garlsson).
 7. **Standard winy i obrona należytej staranności** dla osób zarządzających (art. 69b); zakaz automatyzmu w karaniu zarządu za sporne rozstrzygnięcia medyczno-naukowe.
 8. **Ścieżka sądowej kontroli merytorycznej** decyzji RPP (model SOKiK, zgodnie z TK SK 27/03); rezygnacja z rygoru natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy.
 9. **Wydłużenie vacatio legis** do co najmniej 6 miesięcy zgodnie z linią TK (K 47/14, 14.10.2015) + pełne przepisy intertemporalne.
 10. **Uzupełnienie OSR** projektu o dane ilościowe skali zjawiska (liczba pseudomedyków, skala finansowa, liczba poszkodowanych pacjentów, ocena skuteczności istniejących instrumentów) — zgodnie z art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów.
-

D. TABELA SYNOPTYCZNA: PRZEPIS → PROBLEM → PROPOZYCJA

Przepis projektu

Art. 67zj ust. 1
Art. 67zj ust. 1 (paradoks 1)
Art. 67zj ust. 1 (paradoks 2)
Art. 64a ust. 1–2
Art. 64a ust. 3 (z ust. 4)
Art. 47 ust. 1b / 64 ust. 4a / 67zl ust. 5
Art. 67zl ust. 4
Art. 69b
Art. 70
Vacatio legis (3 miesiące)
Brak przepisu (klauzule)
Brak przepisu (koordynacja)
OSR projektu

WNIOSEK

Projekt UD207 wymaga nie korekt redakcyjnych, lecz gruntownej przebudowy konstrukcyjnej. Cel regulacji jest legitymowany społecznie — narzędzie nie przeszło testu proporcjonalności, określoności ani zgodności z prawem procesowym i prawem UE. Jeżeli MZ nie przeprowadzi przebudowy w procesie sejmowym, projekt generuje wysokie ryzyko:

— **skargi konstytucyjnej** do TK po wejściu ustawy w życie (przede wszystkim co do art. 67zj, art. 64a ust. 3–4, art. 67zl ust. 4, art. 69b); — **skarg do ETPC** w trybie art. 6, 8 i 10 EKPC w sprawach indywidualnych; — **pytania prejudycjalnego do TSUE** w zakresie zgodności z dyrektywą 2005/29/WE, dyrektywą 2001/83/WE, RODO, DSA i EMFA; — **niezależnej krytyki ze strony środowiska pracodawców** systemu ochrony zdrowia — co już ma miejsce (stanowisko 7 organizacji z lipca 2025 r.).

Niezależnie od ostatecznej decyzji parlamentu projekt powinien zostać uzupełniony o klauzule wyłączające dla nauki, dziennikarstwa, sygnalistów, świadomego wyboru pacjenta i legalnych terapii w trybach UE — bez tych klauzul ryzyko skutku mrożącego dla onkologii eksperymentalnej, debaty naukowej i autonomii pacjenta jest poważne.

ŹRÓDŁA I PODSTAWY

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego: K 11/94, P 19/06, P 46/13, K 17/97, K 18/03, P 26/06, P 32/12, P 124/15, SK 27/03, K 1/14, K 13/01, K 47/14, K 22/06, K 14/07, P 29/13.

ETPC: Engel v. Holandia (8.06.1976), Frankowicz v. Polska (53025/99, 16.12.2008), Hertel v. Szwajcaria (25181/94, 25.08.1998), Pretty v. UK (2346/02, 29.04.2002), Vavříčka v.

Czechy (8.04.2021), Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia (302/02, 10.06.2010), Allenet de Ribemont v. Francja (10.02.1995), Khuzhin v. Rosja (23.10.2008), Sergey Zolotukhin v. Rosja (Wielka Izba, 10.02.2009), A i B v. Norwegia (Wielka Izba, 15.11.2016).

TSUE: Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate (C-537/16), VTB-VAB (C-261/07), Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08), Ter Voort (C-219/91), HLH Warenvertrieb (C-211/03).

Polskie sądownictwo: SN III KK 212/18 (5.06.2019); SN 10.02.2010 (autonomia terapeutyczna); SN postanowienie z grudnia 2025 r. (Izba Odpowiedzialności Zawodowej, kasacja w sprawie dr. N. Szalusia); SA Warszawa VI ACa 397/15 (1.04.2016); WSA V SA/Wa 2854/23 (29.10.2025).

Akty prawa UE: dyrektywa 2005/29/WE, dyrektywa 2019/1937 (sygnaliści), dyrektywa 2001/83/WE, rozporządzenie 726/2004, rozporządzenie 2016/679 (RODO), rozporządzenie 2022/2065 (DSA), rozporządzenie 2024/1083 (EMFA).

Akty prawa krajowego: Konstytucja RP, KPA, k.k. (art. 286), ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentystry (art. 4, art. 58), Prawo farmaceutyczne, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie sygnalistów (14.06.2024), Prawo prasowe, Prawo przedsiębiorców, Regulamin pracy Rady Ministrów.

Dokumenty rządowe i stanowiska publiczne: KPRM, karta projektu UD207 wersja 4.0 z 13.05.2026 (legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12398957); stanowisko 7 organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia (Pracodawcy dla Zdrowia, Lewiatan, Pracodawcy RP i in.), lipiec 2025 (pracodawcydlaздrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stnowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf).

Piśmiennictwo naukowe: Naujokat C., Steinhart R., *Salinomycin as a drug for targeting human cancer stem cells*, J Biomed Biotechnol 2012;2012:950658 (DOI 10.1155/2012/950658); Makowska M., Mulinari S., Ozieranski P. (2025), PMID 39726201, PMC11977834.

ZAŁĄCZNIK — POWIĄZANE DOKUMENTY PAKIETU OBYWATELSKIEGO UD207 v1.10

— **Załącznik 1 Policy Paper EBM v1.10** (Część B, Sekcja Konstytucyjna v3.0) — pełna analiza w 13 paragrafach — **Analiza prawna UD207 — wersja 2.0** (autor: M., po korektach Perplexity v13/v14/v15 + ChatGPT v14) — pełen tekst 16 stron — **Dokument A Stanowisko v3.9 + Załącznik 2 Model Tor 2 v1.4 + Wytyczne Salinomycyna v1.1 — Apel do Prezydenta RP** (wersja warunkowa do aktywacji po Sejmie i Senacie) i **Apel do Prezydenta RP v2 ACTIVATED — Brief Medialny** (7 propozycji artykułów), **Memo Ekonomiczne NFZ, Petycja Publiczna, List Otwarty Lekarzy, List Przewodni do**

Komisji Zdrowia Sejmu — MEMO_DECYZYJNE v3.11 (mapa pakietu z odsyłaczami,
glosariusz, skonsolidowana bibliografia)

*Memorandum opracowane na potrzeby pakietu obywatelskiego UD207. Nie stanowi opinii
prawnej w rozumieniu obrotu profesjonalnego. Koordynacja pakietu: Jarek Kędzierski,
jarun@wp.pl. Warszawa, 16 maja 2026 r.*